核心精讲·心肌疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、心肌病

（一）分类

①**原发**性/**特发**性心肌病（原因不明）：**扩张型心肌病 DCM（最常见）**、肥厚型心肌病HCM、限制型心肌病 RCM、致心律失常性右室心肌病

明确病因

天天师兄

②**继发**性/**特异**性心肌病：**克山病**（地方性心肌病）、酒精性心肌病、围生期心肌病、药物性心肌病

缺硒　　与妊娠有关

③未分类心肌病

VS 中老年人出现心源性猝死基本上是冠心病导致

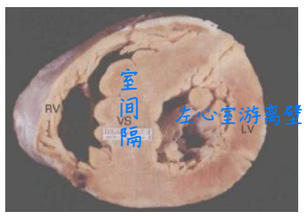
（二）肥厚型心肌病是青年猝死最常见的原因

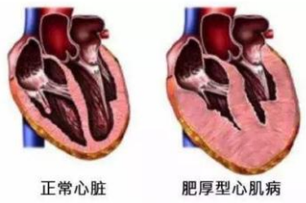
1.**常**染色体**显**性遗传 常显肥

2.病理变化

肥厚不均匀 VS 高血压:左心室均匀肥厚

①心**室**明显**非对称肥厚**（心房没有肥厚）：左心室和或右心室肥厚，**尤其室间隔肥厚**，**室间隔厚度大于左心室游离壁**（两者之比＞1.3）



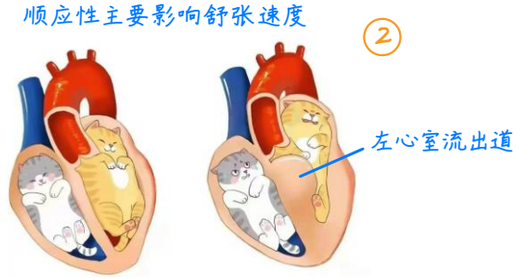


心肌肥厚(胖胖不灵活)主要影响舒张回血,舒张期顺应性下降(影响舒张速度/抽吸)

②心室腔变小（左室显著），左心室充盈受阻和**舒张期顺应性下降**

顺应性主要影响舒张速度


图 9-28　肥厚型心肌病
室间隔非对称性肥厚,心室腔及左心室流出道狭窄。



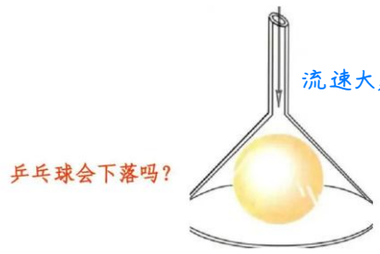
左心室往主动脉射血,大量血液通过狭窄的流出道,血流速度变快,局部压强变低,甚至可以形成负压,把二尖瓣吸引过来,二尖瓣吸过来后会加重狭窄

① 高血压导致左心室向心性肥厚是因为左心室后负荷增加,此为均匀对称的肥厚。
肥心病是遗传因素导致的左心室非对称性肥厚。

② 肥胖的人通常身体不灵活。肥厚的心肌细胞主要影响舒张期。心肌舒张障碍,顺应性下降,则舒张期的抽吸作用减少。左心室的回血减少,充盈受阻。

漏斗效应,超声心动图可看到SAM现象

③由于**收缩期二尖瓣**向前移动与室间隔左侧 ttsx 心内膜接触，可引起**二尖瓣增厚**、**主动脉瓣下心内膜增厚**（左室流出道狭窄/肥厚型梗阻型心肌病，不是主动脉瓣狭窄）



③

伯努利原理:在水流或气流里,如果速度小,压强就大,如果速度大压强就小

（三）扩张型心肌病

1.**免疫介导**的心肌损害 病毒感染

2.病理变化

①**左心室开始且显著扩张，后期各心腔均可扩张（临床常有心界向两侧扩大）** ④

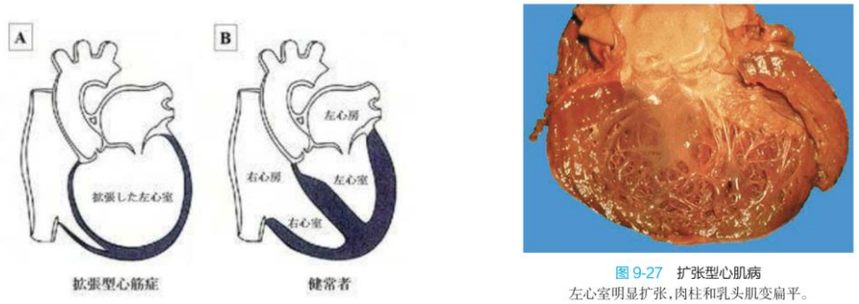


图 9-27　扩张型心肌病
左心室明显扩张,肉柱和乳头肌变扁平。

④

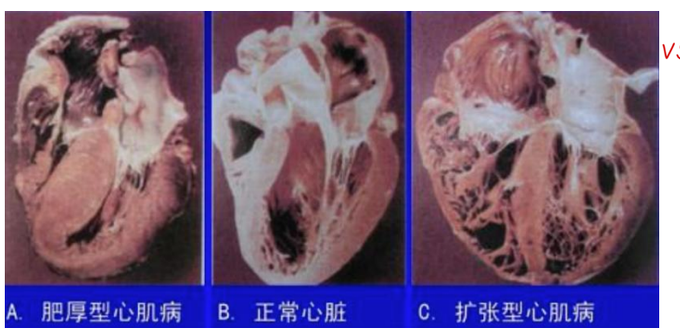
肥心病是心室的肥厚,尤其是室间隔的肥厚,心房不会肥厚。
心界向两侧扩大首先考虑:扩张型心肌病、心包积液。

标本因为纤维化可以让室壁正常或略厚

②心室壁变**薄**、略厚或正常，心尖部室壁常呈钝圆形，**心内膜增厚**　室壁（总体变薄）：心内膜:有附壁血栓,纤维化→增厚；心肌；心外膜　⑤

代偿

③萎缩和肥大的心肌细胞交错排列，心肌细胞损伤（变性、坏死），**收缩**功能障碍，**室壁运动普遍/弥漫减弱**（VS 肥厚型心肌病心肌细胞弥漫性肥大）　⑥



VS：肥心病:舒张功能障碍；扩心病:收缩功能障碍

⑤

免疫损伤心肌细胞,同时,心肌扩张，心肌应变薄。但《病理学》中认为心肌还可以变厚。因为心肌损害后,根据病理学的基本逻辑,此处应该有肉芽组织进行修复,出现纤维化。而纤维化的组织是可让心肌变厚的。
此外,应该注意文字叙述。扩心病的心室壁变薄,但是心内膜是增厚的。由于心腔的扩张,血流动力学发生变化,心腔中易形成湍流,从而导致一些附壁血栓的形成。加之纤维化,所以心内膜是增厚的。

⑥

心肌细胞的肥大是在肥厚性心肌病和扩张型心肌病中均可出现的。肥厚性心肌病是遗传导致。扩张型心肌病中,部分心肌细胞坏死,其余心肌细胞代偿导致的肥大。

（四）限制型心肌病 舒张功能障碍为主

①**心内膜及心内膜下心肌纤维化**（纤维性增厚），以心尖部为重，**酷似缩窄性心包炎** ⑦

（缩心炎外套太紧、限心病内衣太紧）

②心室腔狭窄，心室充盈受限和舒张期容量减少

（五）致心律失常性右室心肌病（幼稚）

右心室心肌被**脂肪**组织或纤维脂肪组织进行性替代→**右**心室进行性扩大、难治性右心衰

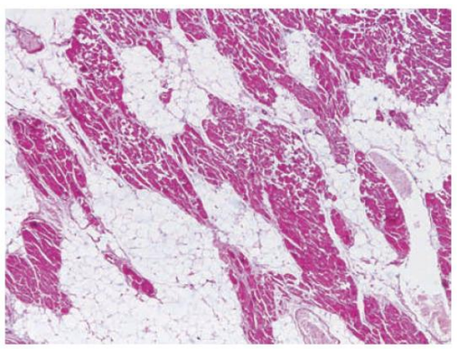


图 9-29　致心律失常性右室心肌病
右心室局部被脂肪组织所替代。

（六）克山病（缺硒）

①两侧心腔扩大，心室壁变薄，以心尖部为重，心脏呈球形（类似扩心病）

②心肌严重变性（水肿、空泡变性、脂肪变性）、坏死、瘢痕形成

注意：上述心肌病均可有**房室瓣关闭不全**、心衰、栓塞（**附壁血栓**脱落）、猝死（肥厚型心肌病最常见） ⑧

①心腔扩大后门框变大，但是门没有变大（相对性关闭不全）
②肥心病关闭不全是因为漏斗效应，收缩期时血通过狭窄的流出道速度快，压强低，把二尖瓣吸引过来，收缩期二尖瓣本来应该是关闭的，此时却因为负压被吸引过来导致关闭不全

二、心肌炎

（一）病毒性心肌炎

1.相关病毒：**柯萨奇 B 组（最常见）**、柯萨奇 A 组、埃可、腺、流感、风疹、巨细胞、肝炎病毒等

《内科学》：柯萨奇 B 组（最常见）、埃可、脊髓灰质炎、腺、流感、细小、冠状病毒等

⑦

2.区别

	限制型心肌病	缩窄性心包炎
病因	“电线”淀粉样变等	结核、急性非特异性心包炎等 渗出纤维素
病理	心内膜及心内膜下心肌纤维化（内衣太紧）	心包粘连增厚、钙化（外套太紧）
体征	**无奇脉** 心肌病都无奇脉	可有奇脉、心包叩击音（特点）、负性心尖搏动、室间隔抖动征

奇脉：严重的色魔小说包邮

⑧

多数心肌病晚期时都会出现心腔的扩大。瓣膜的瓣环同样会牵拉变大。造成一个相对性的瓣膜关闭不全。肥厚性心肌病同样会出现瓣膜的关闭不全。与漏斗效应有关。收缩期时，左心室向主动脉中射血，高速血流通过狭窄的流出道，导致局部压力降低。二尖瓣被吸引出现前移。在收缩期时，二尖瓣应闭合，避免血液的反流进入左心房。但是二尖瓣的前移，导致二尖瓣的关闭不全。

2.病理变化（有实质性病变、间质性病变，以**间质性病变为主**）　⑨

①心肌细胞损伤、心肌纤维化 实质病变

病毒感染主要是淋巴细胞、单核细胞的浸润

②心肌细胞间**淋巴细胞和单核细胞**浸润，将心肌分割呈条索状（心肌细胞变细）间质病变

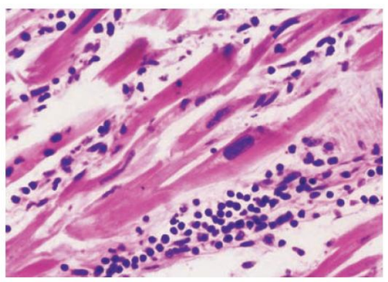


图 9-32　心肌炎

心肌细胞间和间质可见大量的淋巴细胞、单核细胞浸润，多数心肌细胞变细，可见散在的肥大的心肌细胞。

（二）细菌性心肌炎

多发小脓肿（中性粒细胞浸润）

（三）特发性/孤立性/Fiedler 心肌炎

①弥漫性间质性心肌炎

②特发性巨细胞性心肌炎：肉芽肿形成

（四）免疫反应性心肌炎

偶见肉芽肿形成

（**有肉芽肿形成的心肌炎：特发性巨细胞性心肌炎、免疫反应性心肌炎、风湿性心肌炎**）

真题解析·心肌疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N48 A 扩张型心肌病肉眼检查不包括的主要病理变化是

A.心脏重量增加达 500-800g 射不出去血，装在心脏里面

B.两侧心腔扩张 各个心腔都可以扩张

C.二尖瓣、三尖瓣关闭不全 门框变大

D.心内膜增厚

扩心病:有血射不出 VS 肥心病:没血可以射

⑨ 心肌细胞是不可再生细胞，所以心肌细胞发生损伤后会有纤维化的修复。

2.2015N163 X 肥厚型心肌病其肉眼病理变化有

A.左心室壁肥厚 心室不对称肥厚(室间隔明显肥厚)

B.室间隔不均匀肥厚

C.二尖瓣肥厚

D.左心房壁肥厚

3.2023N152 X 可引起心肌坏死的病变有

A.病毒性心肌炎

B.主动脉粥样硬化 瓣膜狭窄或关闭不全一样可以导致心肌坏死

C.肺动脉瓣狭窄 右心室向心性肥厚→离心性肥厚

D.扩张型心肌病 免疫介导心肌损害

思维导图·心肌疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案: 2-3 ABC ABCD